헬리코박터 파일로리 개요·진단 안내

감염 의미, 내시경 소견, 진단검사, 치료 필요성을 한 번에 정리합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국 성인 약 3명 중 1명이 감염돼 있습니다

위생 환경이 좋아지며 줄었지만 여전히 흔합니다 — 그리고 대부분은 증상이 없습니다

30%

한국 성인 감염률

1998년 약 67%에서 줄었지만 여전히 높습니다

80~90%

평생 증상 없음

감염자 대부분은 별다른 증상 없이 지냅니다

6배

위암 위험

감염되면 위암 위험이 약 6배 높아집니다

왜 중요한가요

일부에서는 만성 위염·소화성 궤양·위암으로 진행합니다. 세계보건기구 국제암연구소는 헬리코박터를 1군 발암 요인으로 분류합니다.

그래서 이렇게 합니다

감염된 모든 분을 치료하기보다, **정확히 진단하고 치료가 필요한 분을 골라 제균**하는 것이 원칙입니다.

Tip · 감염 자체보다 '누가 치료가 필요한지'를 가리는 것이 핵심입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 국제암연구소(IARC)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강한 위산 속에서 살아남는 세균입니다

위 점막에 평생 자리잡고, 오랜 염증으로 여러 위장 질환의 출발점이 됩니다

01

위산을 견딥니다

스스로 만드는 효소(요소분해효소)로 주변 위산을 중화하고, 나선형 몸과 꼬리털로 위 점막 깊이 파고듭니다.

위산 속에서도 생존

02

저절로 없어지지 않습니다

한 번 감염되면 평생 지속되며, 만성 염증을 통해 여러 위장 질환이 시작됩니다.

치료해야 없어집니다

03

한국 균은 더 독합니다

위 세포에 발암 과정을 돕는 단백질(CagA)을 넣는 균이 있습니다. 한국·일본 균 대부분이 이 형태로 알려져 있습니다.

위암 위험이 더 높은 형태

Tip · 그래서 한국에서는 헬리코박터와 위암의 연관이 특히 중요하게 다뤄집니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 국제암연구소(IARC) 1군 발암 요인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

대부분 어린 시절 가족 안에서 감염됩니다

어른끼리 새로 옮는 경우는 드뭅니다

입에서 입으로 — 가장 흔함

식기·수저·컵을 같이 쓰거나 음식을 나눠 먹을 때 침으로 옮습니다. 찌개·반찬을 함께 먹는 문화에서 가족 내 감염이 흔합니다.

오염된 물·음식

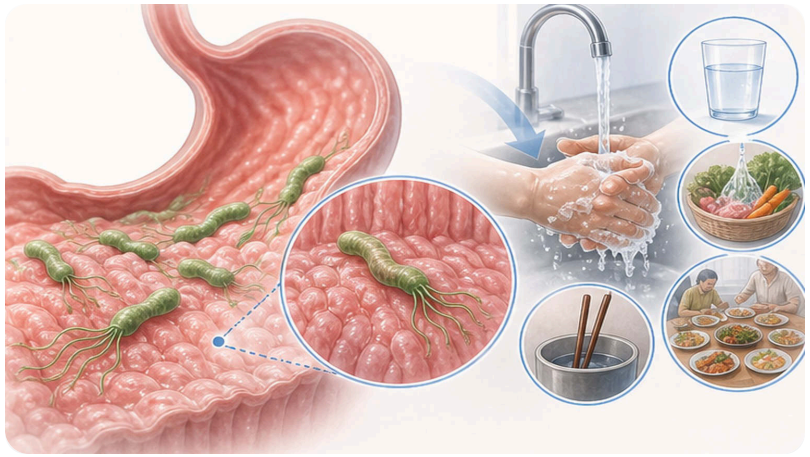
감염된 사람의 대변에 오염된 손·물·음식으로 옮을 수 있어 손 씻기와 식수 위생이 중요합니다.

5세 이전이 핵심

대부분 5세 이전에 감염되며, 부모가 감염돼 있으면 자녀 감염 위험이 크게 높아집니다.

제균 뒤 재감염은 드묾

성인의 재감염은 한 해 약 2~3%로 낮아, 제균에 성공하면 대부분 그대로 유지됩니다.



설명용 그림 · 위 점막의 헬리코박터(확대)와 손 씻기·식수·함께 먹는 식탁 — 대표적인 감염 경로입니다.

Tip · 가족 중 제균한 분이 있으면 다른 가족의 검사 여부도 함께 상의하세요.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

감염되면 어떻게 진행되나요

대부분은 증상 없이 지나가지만, 일부는 위암으로 가는 단계를 밟습니다

1

만성 위염

80~90%

감염자 대부분은 증상 없는 만성 위염 상태로 평생 지냅니다.

2

소화성 궤양

10~15%

위·십이지장 궤양이 생겨 명치 통증·속쓰림이 나타나고, 출혈·천공 위험이 있습니다.

3

위축 → 장상피화생

수십 년

오랜 염증으로 위 점막이 얇아지고 장 점막처럼 바뀝니다. 위암 전 단계 변화입니다.

4

위암 · 말트 림프종

0.1~3%

일부가 위암으로 진행하고, 드물게(0.01% 미만) 위 말트 림프종이 생깁니다. 일찍 찾고 제균하는 것이 핵심입니다.

Tip · 위암까지 가는 분은 일부입니다 — 단계마다 멈출 기회가 있습니다.

근거 · 코레아 위암 발생 단계 · Int J Oncol 2006 · N Engl J Med 2001 · Lancet 2008

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내시경에서는 이렇게 보입니다

조직 검사뿐 아니라 점막의 모양도 감염의 단서가 됩니다

비교적 초기 — 붉어지고 붓습니다

점상 출혈반·점상 발적, 넓게 붉어진 점막, 점막 부종이 보일 수 있습니다. 염증이 활발한 시기의 단서입니다.

오래된 감염 — 얇아지고 바뀝니다

위 점막이 얇아지는 위축, 장 점막처럼 바뀌는 장상피화생이 함께 보일 수 있습니다. 위암 위험과 추적 간격을 정할 때 중요합니다.

특징적 변화 — 오돌토돌한 결절

점막이 오돌토돌하게 솟는 결절 변화(림프여포성 위염)는 헬리코박터 감염에서 보이는 대표적 소견입니다.

제균 뒤 — 좋아질 수 있습니다

붉어짐·부종·결절은 제균 뒤 줄어들 수 있습니다. 다만 위축과 장상피화생은 따로 추적이 필요할 수 있습니다.

Tip · 내시경 결과지에 이런 표현이 있으면 헬리코박터 검사 결과와 함께 설명을 들으세요.

근거 · 교토 위염 분류 연구 2020 · 대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어떻게 진단하나요

한국에서는 내시경을 할 때 함께 진단하는 경우가 많습니다

검사	방법과 특징
신속요소분해효소 검사(CLO)	내시경 때 떼어 낸 조직으로 바로 검사 · 30분~24시간 안에 결과, 한국에서 가장 흔함
조직검사	현미경으로 확인 · 위축·장상피화생도 함께 평가
세균 배양	잘 듣는 항생제 확인 · 두 번 실패한 뒤 맞춤 치료에 결정적
요소호기검사	약을 마신 뒤 내쉰 숨으로 검사 · 정확도 95% 이상, 치료 후 확인의 표준
대변 항원검사	대변으로 검사 · 어린이·고령자도 부담이 적음
혈액 항체검사	과거 감염도 양성 · 치료 후 확인에는 쓰지 않음



설명용 그림 · 왼쪽 위는 요소호기검사, 왼쪽 아래는 대변 검사, 오른쪽은 내시경으로 조직을 떼어 검사하는 모습입니다.

Tip · 처음 진단은 어느 검사로든 할 수 있고, 치료 뒤 확인은 요소호기검사나 대변 항원검사로 합니다.

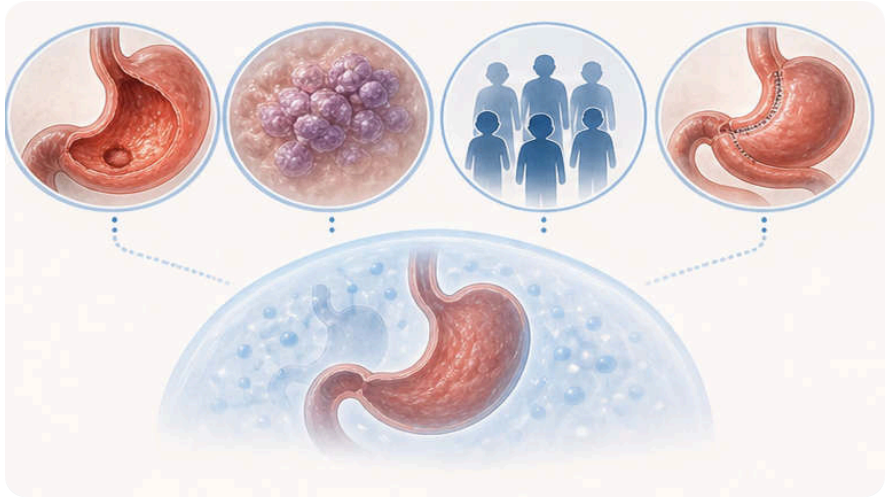
근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

제균 치료를 권하는 여섯 가지

1~4번은 지침이 강하게 권하고, 5·6번(가족력·위축성 위염)은 상의해 정합니다

1. **소화성 궤양** 지금·과거
   위·십이지장 궤양 — 제균하면 재발이 크게 줄어듭니다.
2. **위 말트 림프종** 초기
   제균만으로 좋아질 수 있는 유일한 림프종입니다.
3. **조기 위암 절제 뒤** 약 50%↓
   내시경 절제술 뒤 새 위암이 생길 위험을 줄입니다.
4. **원인 모를 혈소판 감소** 약 50% 호전
   특발성 혈소판감소성 자반증에서 혈소판이 좋아집니다.
5. **위암 가족력** 보험 적용
   부모·형제 중 위암 환자가 있는 경우입니다.
6. **위축성 위염·장상피화생** 위암 전 단계
   진행을 늦추거나 막을 수 있어 검토를 권합니다.



설명용 그림 · 궤양·림프종·가족력·위암 절제 뒤 — 제균을 강하게 권하는 대표적인 경우입니다.

Tip · 해당한다면 제균 치료를 미루지 않는 것이 좋습니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022 · 건강보험 적용 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이득과 부담을 따져 함께 정하는 경우

진료지침이 조건부로 권하는 경우 — 상의 후 결정합니다

01

아스피린·소염진통제를 오래 드실 때

궤양 병력이 있다면 제균을 권합니다. 위장 출혈 위험을 낮춥니다.

궤양 병력이 있으면

02

원인 모를 철결핍 빈혈

출혈 원인이 분명하지 않은 만성 빈혈에서 제균 뒤 좋아진 보고가 있습니다.

검토 대상

03

기능성 소화불량

반복되는 명치 불편·식후 더부룩함이 있는 일부에서 제균 뒤 증상이 좋아집니다.

다른 이유와 함께 검토

04

본인이 치료를 원할 때

이득과 부작용·항생제 내성을 충분히 설명들은 뒤 원하면 진행할 수 있습니다.

충분히 설명 듣고

Tip · 조건부 권고는 '해도 되고 안 해도 된다'가 아니라 '상황을 보고 함께 정한다'는 뜻입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

검사를 권하는 경우와 권하지 않는 경우

검사하면 치료까지 — 치료할 생각이 있을 때만 검사하는 것이 원칙입니다

검사를 권하는 경우

양성이면 제균 치료로 이어집니다

- 위·십이지장 궤양이 발견됐을 때
- 가족 중 위암 환자가 있을 때
- 위축성 위염·장상피화생으로 진단됐을 때
- 아스피린·소염진통제를 오래 먹고 궤양 병력이 있을 때
- 원인 모를 철결핍 빈혈·혈소판 감소
- 조기 위암을 떼어 낸 뒤 추적할 때

vs

일반적으로 권하지 않는 경우

검사해도 도움이 적거나 결과가 부정확합니다

- 증상이 전혀 없는 일반 건강인
- 위장 증상이 가볍고 일시적일 때
- 치료할 생각이 없을 때(검사가 의미 없음)
- 위산억제제·항생제를 먹은 직후(음성으로 잘못 나올 수 있음)
- 임신 중
- 매우 고령으로 기대 수명이 짧을 때

Tip · 급성 출혈 때 시행한 검사에서 음성이면 지혈 후 다시 확인할 수 있습니다.

근거 · 유럽소화기내시경학회(ESGE) 출혈 지침 2021

제균 치료는 단계적으로 합니다

처방에 따라 동시요법 10일 또는 표준 삼제요법 14일을 복용하고, 치료 후 균이 없어졌는지 확인합니다

70~85%

1차 치료 성공률

최근 국내 조사(2021~2023년): 내성률 약 33%

95%+

단계별 누적 성공률

1·2차, 필요하면 맞춤 3차까지

4주+

치료 끝나고 확인까지

요소호기검사·대변 검사로 확인

성공의 열쇠는 빠짐없이 먹기

한 알도 빼먹지 않고 끝까지 먹는 것이 핵심입니다. 스스로 끊으면 약이 안 듣는 균이 생겨 다음 치료까지 어려워집니다.

치료 중에는 금주

메트로니다졸 복용 중과 마지막 복용 뒤 72시간 금주하세요. 자세한 약과 주의사항은 '제균 치료 안내' 자료를 보세요.

Tip · 약 조합·부작용·복용 규칙은 별도 '헬리코박터 제균 치료 안내' 자료에 자세히 있습니다.

근거 · 대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 일곱 가지

감염·진단·치료 결정의 핵심입니다

01 한국 성인 약 30%가 감염 — 대부분은 증상이 없습니다

02 감염은 주로 어린 시절 가족 안에서 일어납니다

03 위암 위험을 약 6배 높이는 1군 발암 요인입니다

04 진단은 내시경 조직 검사나 요소호기검사·대변 검사로

05 궤양·말트 림프종·조기 위암 절제 뒤·혈소판 감소는 꼭 제균

06 치료가 끝나고 4주 이상 지나 제균 확인 검사

07 가족도 검사·치료를 함께 상의하기

Tip · 검사할 거라면 치료할 생각이 있을 때 — 이것이 원칙입니다.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

검사·치료를 앞두고 가장 많이 묻는 네 가지

결정을 앞두고 궁금한 점을 먼저 정리했습니다



설명용 그림 · 치료할지는 이득과 부담을 저울질해 의사와 함께 정합니다.

? 감염되면 꼭 치료해야 하나요?

모두가 바로 치료 대상은 아닙니다. 궤양·말트 림프종·조기 위암 치료 뒤·혈소판 감소는 꼭, 위암 가족력·위축성 위염은 상의해 권합니다.

제균 뒤 다시 감염되나요?

성인 재감염은 한 해 2~3% 정도로 낮습니다. 성공하면 대개 오래 유지됩니다.

가족에게 옮나요?

주로 어린 시절 가족 안에서 옮습니다. 어른끼리는 드물지만, 가족력이 있으면 검사를 함께 상의합니다.

약과 부작용은 어디서 보나요?

약 이름·먹는 시간·금주·부작용·병원에 올 신호는 '제균 치료 안내' 자료에 있습니다.

Tip · 그 밖에 궁금한 점은 진료 때 편하게 물어보세요.

근거 · 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

헬리코박터 감염이 궁금하거나 검사를 권유받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 치료 여부는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한상부위장관·헬리코박터학회 진료지침 2025 · 국제암연구소(IARC) 발암물질 분류 · 교토 위염 분류 2014

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 제균 치료 슬라이드 edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/h-pylori/eradication/